Hồ sơ thực hiện tiêu chí C6.2

Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh khi điều trị và trước khi ra viện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN — PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Bản dự thảo phục vụ triển khai và tự đánh giá năm 2026. Hồ sơ này cung cấp quy định đề xuất, kế hoạch, công cụ giám sát và biểu mẫu để bệnh viện hoàn thiện bằng dữ liệu thực tế. Chưa có căn cứ kết luận bệnh viện đạt mức nào của C6.2.

Số văn bản và phiên bản chính thức .....

Ngày phê duyệt và ngày áp dụng .....

Người soạn thảo .....

Người rà soát .....

Người phê duyệt .....

Phạm vi và cách sử dụng

Áp dụng cho hoạt động tư vấn tại các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh và các bộ phận phối hợp. Chỉ tiêu tư vấn nội trú được theo dõi riêng. Mã biểu mẫu trong hồ sơ là mã đề xuất, cần thống nhất với hệ thống quản lý tài liệu của bệnh viện trước khi ban hành.

Đây là hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe, không phải quy trình kỹ thuật lâm sàng nên không áp đặt đề cương QĐ3023. Các kỹ thuật được hướng dẫn cho người bệnh phải dựa trên tài liệu chuyên môn tương ứng và phạm vi được phép thực hiện.

Trước khi ký: bổ sung thông tin hành chính; xác nhận đầu mối, nguồn lực và thời hạn; phê duyệt nội dung; phổ biến đến đơn vị. Chỉ đưa minh chứng đã thực hiện vào hồ sơ đánh giá, không dùng biểu mẫu trống thay cho kết quả.

1 Căn cứ và nguyên tắc đánh giá

Căn cứ đối chiếu chính: Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, tiêu chí C6.2, trang in 93–94 [1]. Nhiệm vụ tư vấn của điều dưỡng được đối chiếu điểm i khoản 1 Điều 6 Thông tư 31/2021/TT-BYT [2], thay cho việc viện dẫn Thông tư 07/2011/TT-BYT như văn bản đang áp dụng.

Bệnh viện đối chiếu thêm hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng áp dụng cho kỳ đánh giá thực tế. Hồ sơ này không thay thế toàn bộ yêu cầu của Thông tư 35/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện [3].

Cách ghi kết quả

Hai tiểu mục mức 1 mô tả tình trạng không bảo đảm chất lượng: không có quy định hoặc không có tài liệu. Khi tự đánh giá phải kiểm tra các tình trạng này trước; không đánh dấu “đạt” chỉ vì bệnh viện không có quy định hoặc tài liệu.

Đánh giá theo nguyên tắc của Bộ tiêu chí: có tình trạng thuộc mức 1 thì xếp mức 1; khi không có tình trạng mức 1, đối chiếu lần lượt các yêu cầu tích lũy của mức 2 đến mức 5 và minh chứng thực tế. Không lấy điểm trung bình các tiểu mục để xếp mức. Chưa đủ bằng chứng thì ghi “chưa xác minh”, không tự suy ra đạt.

Mốc cần kiểm soát	Yêu cầu theo C6.2
Đào tạo điều dưỡng và hộ sinh	Mức 3: ≥50%; mức 4: ≥70%; mức 5: ≥90%.
Tư vấn người bệnh nội trú	Tiểu mục 8 mức 3: ≥50% được điều dưỡng hoặc hộ sinh tư vấn.
Nhu cầu giáo dục sức khỏe	Tiểu mục 15: được đánh giá và ghi vào phiếu chăm sóc.
Hiệu quả và cải tiến	Tiểu mục 17–19: đánh giá, phản hồi kết quả và thực hiện cải tiến.

Không có số liệu đào tạo, tư vấn hoặc khảo sát thì để trống kết quả. Tỷ lệ 70% và 90% nêu trên là ngưỡng đào tạo nhân viên; không chuyển thành ngưỡng bắt buộc về tỷ lệ người bệnh được tư vấn.

2 Ma trận yêu cầu từ mức 1 đến mức 3

Diễn giải rút gọn từ [1]; dùng cùng văn bản gốc khi đánh giá. Mục 1–2 là tình trạng bất lợi; các mục còn lại là yêu cầu cần đáp ứng.

Mục và mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
1 / M1	Không có quy định cụ thể về tư vấn, giáo dục sức khỏe	Kiểm tra sự hiện diện, hiệu lực và nội dung quy định.
2 / M1	Không có tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe	Kiểm tra thực tế kho tài liệu và tại khoa.
3 / M2	Sẵn có tài liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành	Tài liệu, nguồn phát hành, danh mục tiếp nhận.
4 / M3	Phổ biến tài liệu cho nhân viên, người bệnh, người nhà; dễ thấy, dễ lấy	Biên bản phổ biến; quan sát điểm trưng bày và cấp phát.
5 / M3	Ban hành quy định hoặc hướng dẫn cụ thể	Văn bản được phê duyệt, danh sách phổ biến.
6 / M3	Ít nhất 50% điều dưỡng, hộ sinh được tập huấn kỹ năng	Danh sách nhân sự, chương trình, hồ sơ tập huấn và phép tính.
7 / M3	Nhân viên thực hiện đầy đủ quy định của bệnh viện	Quan sát, phỏng vấn và hồ sơ chăm sóc.
8 / M3	Ít nhất 50% người bệnh nội trú được điều dưỡng, hộ sinh tư vấn	Dữ liệu nội trú và ghi nhận tư vấn có thể truy vết.
9 / M3	Có danh mục ưu tiên theo mô hình bệnh tật và lộ trình tài liệu	Phân tích bệnh tật, danh mục và kế hoạch.

Đầu mối tổng hợp: Phòng Điều dưỡng phối hợp bộ phận Quản lý chất lượng. Mỗi bằng chứng cần mã, ngày, đơn vị lưu và vị trí tra cứu; ảnh hoạt động đơn lẻ không chứng minh được tỷ lệ bao phủ.

3 Ma trận yêu cầu mức 4 và mức 5

Diễn giải rút gọn từ [1]; dùng cùng văn bản gốc khi đánh giá. Mục 1–2 là tình trạng bất lợi; các mục còn lại là yêu cầu cần đáp ứng.

Mục và mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
10 / M4	Phòng hoặc tổ điều dưỡng chủ trì hay tham gia xây dựng tài liệu	Phân công, bản thảo và nguồn tham khảo trong nước, quốc tế.
11 / M4	Tài liệu bệnh viện xây dựng được thảo luận, phê duyệt đúng thẩm quyền	Biên bản góp ý, văn bản phê duyệt, bản được kiểm soát.
12 / M4	Ít nhất 70% điều dưỡng, hộ sinh được tập huấn	Hồ sơ đào tạo và tỷ lệ trên danh sách nhân sự thực tế.
13 / M4	Tư vấn phù hợp lúc vào viện, điều trị và ra viện	Ghi nhận theo ba thời điểm; phỏng vấn người bệnh.
14 / M4	Người bệnh có kiến thức và kỹ năng thiết yếu	Kiểm tra nhắc lại, thực hành lại theo nội dung phù hợp.
15 / M4	Đánh giá nhu cầu giáo dục sức khỏe, ghi phiếu chăm sóc	Phiếu chăm sóc hoặc hồ sơ điện tử được bệnh viện chấp thuận.
16 / M5	Ít nhất 90% điều dưỡng, hộ sinh được tập huấn	Hồ sơ đào tạo và tỷ lệ được xác minh.
17 / M5	Đánh giá hiệu quả, xác định tồn tại và đề xuất cải tiến	Đề cương, dữ liệu, báo cáo đánh giá hoặc nghiên cứu.
18 / M5	Công bố, thông báo và phản hồi kết quả tới khoa liên quan	Thông báo, biên bản họp, thư nội bộ hoặc bằng chứng tiếp nhận.
19 / M5	Thực hiện cải tiến từ kết quả đánh giá	Kế hoạch khắc phục, bằng chứng thực hiện, đánh giá lại.

Đầu mối tổng hợp: Phòng Điều dưỡng phối hợp bộ phận Quản lý chất lượng. Mỗi bằng chứng cần mã, ngày, đơn vị lưu và vị trí tra cứu; ảnh hoạt động đơn lẻ không chứng minh được tỷ lệ bao phủ.

4 Quy định đề xuất về tư vấn giáo dục sức khỏe

Mục đích và trách nhiệm

Giúp người bệnh và người chăm sóc hiểu tình trạng sức khỏe, phối hợp điều trị, thực hiện chăm sóc phù hợp và biết khi nào cần liên hệ nhân viên y tế. Tư vấn tôn trọng quyền riêng tư, ngôn ngữ, khả năng tiếp nhận và lựa chọn của người bệnh.

Đơn vị hoặc chức danh	Trách nhiệm
Ban Giám đốc	Phê duyệt quy định, tài liệu và nguồn lực theo thẩm quyền; chỉ đạo khắc phục tồn tại.
Phòng Điều dưỡng	Điều phối, xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo, giám sát và tổng hợp dữ liệu.
Bộ phận Quản lý chất lượng	Phối hợp chọn phương pháp đo, xác minh dữ liệu, đánh giá và theo dõi cải tiến.
Trưởng khoa và điều dưỡng trưởng	Phân công nhân viên, bảo đảm tài liệu sẵn có, kiểm tra ghi chép và triển khai tại khoa.
Điều dưỡng và hộ sinh	Nhận định nhu cầu, tư vấn trong phạm vi nhiệm vụ, kiểm tra hiểu biết, ghi phiếu chăm sóc và bàn giao.
Bác sĩ và bộ phận chuyên môn liên quan	Giải thích chẩn đoán, điều trị và nội dung chuyên sâu; phối hợp dược, dinh dưỡng, phục hồi chức năng khi cần.

Nguyên tắc thực hiện

Ưu tiên xử trí cấp cứu trước. Chọn thời điểm người bệnh ổn định và có thể tiếp nhận; nếu chưa thực hiện được, ghi lý do, người nhận thay phù hợp và thời điểm đánh giá lại. Không để tư vấn làm trì hoãn điều trị.

Dùng lời dễ hiểu, chia nhỏ nội dung; hỗ trợ người cao tuổi, hạn chế đọc viết, khiếm thính, khiếm thị hoặc khác ngôn ngữ. Không tư vấn thay đổi thuốc, liều dùng hoặc chế độ điều trị ngoài y lệnh và phạm vi chuyên môn.

5 Các bước thực hiện tại khoa

Bước 1 Nhận định và ghi nhu cầu

Xác định người tiếp nhận; kiến thức sẵn có; ngôn ngữ; khả năng nghe, nhìn, đọc hiểu, ghi nhớ và thực hành; lo lắng, sẵn sàng học; nội dung bệnh lý, thuốc, dinh dưỡng, vận động và chăm sóc cần học. Ghi nhu cầu cụ thể vào phiếu chăm sóc, không chỉ ghi “đã tư vấn”.

Bước 2 Thống nhất mục tiêu

Chọn nội dung ưu tiên theo tình trạng, nguy cơ và mong muốn. Viết mục tiêu có thể kiểm tra, ví dụ người bệnh nhắc lại dấu hiệu cần đi khám hoặc người chăm sóc thực hiện đúng thao tác đã được hướng dẫn.

Bước 3 Tư vấn theo thời điểm

Vào viện: nội quy, an toàn, cách gọi hỗ trợ, phòng ngừa té ngã và nội dung cấp thiết. Trong điều trị: bệnh, thuốc theo y lệnh, dinh dưỡng, vận động, kiểm soát nhiễm khuẩn, tự chăm sóc. Trước ra viện: thuốc theo đơn, tự theo dõi, dấu hiệu cần khám ngay, lịch tái khám, nơi liên hệ đã được bệnh viện xác nhận.

Bước 4 Kiểm tra khả năng tiếp nhận

Đề nghị nhắc lại bằng lời của người bệnh, không chỉ hỏi “đã hiểu chưa”. Với kỹ năng phù hợp, cho thực hành lại dưới giám sát. Nếu chưa đạt, giải thích lại bằng cách khác và đánh giá lại; không quy kết lỗi cho người bệnh.

Bước 5 Ghi chép và bàn giao

Ghi thời gian, người được tư vấn, nhu cầu, nội dung, tài liệu hoặc phiên bản, phương pháp, kết quả nhắc lại hay thực hành lại, nội dung còn thiếu, kế hoạch bổ sung và người thực hiện. Bàn giao phần chưa hoàn thành khi đổi ca, chuyển khoa, chuyển viện hoặc ra viện.

Phiếu BM01 hỗ trợ ghi nhận; thông tin cần được tích hợp hoặc dẫn chiếu rõ vào phiếu chăm sóc/hồ sơ bệnh án theo hệ thống được phê duyệt, tránh lập hồ sơ rời không thể truy vết. Tư vấn nhóm không thay thế đánh giá nhu cầu và hướng dẫn cá thể cần thiết.

6 Quản lý tài liệu và danh mục ưu tiên

Khoa đề xuất chủ đề từ số lượt bệnh, nguy cơ biến chứng, khó khăn tự chăm sóc và phản hồi người bệnh. Phòng Điều dưỡng tổng hợp với số liệu bệnh tật thực tế trước khi xác lập danh mục. Danh sách dưới đây là gợi ý, chưa phải mười bệnh thường gặp của bệnh viện.

Nhóm đơn vị	Chủ đề gợi ý cần xác nhận
Nội và các khoa điều trị bệnh mạn	Đái tháo đường, tăng huyết áp, dùng thuốc và tái khám.
Ngoại và Phẫu thuật gây mê hồi sức	Chuẩn bị phẫu thuật, chăm sóc vết mổ, vận động, dấu hiệu bất thường.
Nhi và đơn vị có hộ sinh	Chăm sóc theo tuổi, dùng thuốc theo đơn, dinh dưỡng và hướng dẫn người chăm sóc.
Truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn	Phòng lây nhiễm và tự theo dõi theo từng bệnh.
Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng	Bài tập được chỉ định, phòng ngã, sử dụng dụng cụ hỗ trợ.
Khám bệnh và các chuyên khoa khác	Nhu cầu phổ biến được xác định từ dữ liệu của đơn vị.

Quy trình kiểm soát tài liệu

Soạn thảo kèm nguồn và ngày tra cứu → chuyên khoa rà soát tính chính xác, an toàn và khả năng áp dụng → thảo luận tại tổ chức có thẩm quyền → phê duyệt theo phân cấp bệnh viện → cấp mã, phiên bản, ngày áp dụng → phổ biến và thu hồi bản lỗi thời. Rà soát khi hướng dẫn thay đổi, có sự cố hoặc theo lịch bệnh viện phê duyệt.

Tài liệu phải dễ đọc, có tên bệnh viện, đối tượng sử dụng, thông điệp chính, hình minh họa phù hợp, nguồn tham khảo và thông tin kiểm soát phiên bản. Tờ rơi dễ lấy; áp phích dễ thấy; bản điện tử truy cập được. QR chỉ bổ sung cho tài liệu đã phê duyệt, phải kiểm tra đường dẫn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bài và tờ bướm đái tháo đường đã soạn là tài liệu ứng viên để chuyên khoa rà soát; chỉ tính là tài liệu được bệnh viện phê duyệt khi có bằng chứng phê duyệt thật. Cần đồng thời có tài liệu do cơ quan có thẩm quyền phát hành để đối chiếu tiểu mục 3.

7 Kế hoạch triển khai và đào tạo

T0 là ngày kế hoạch được phê duyệt thực tế. Không ghi lùi ngày, không lập danh sách tham dự hoặc kết quả thay cho hoạt động chưa diễn ra. Mục tiêu mức cần đạt: [BỔ SUNG sau khảo sát ban đầu].

Thời hạn đề xuất	Công việc và sản phẩm	Đầu mối
T0 đến T0 + 15 ngày	Khảo sát 19 tiểu mục; chốt nhân sự, dữ liệu nội trú, tài liệu sẵn có; xác định khoảng thiếu.	Điều dưỡng, QLCL và các khoa
Đến T0 + 30 ngày	Trình quy định, danh mục ưu tiên, lịch đào tạo, biểu mẫu và phân công; bố trí tài liệu chính thống.	Phòng Điều dưỡng
Đến T0 + 60 ngày	Tập huấn theo ca; thực hành tư vấn; thử công cụ ghi chép, đo lường và sửa bất cập.	Giảng viên được phân công, các khoa
Đến T0 + 90 ngày	Đánh giá bao phủ, hiểu biết và kỹ năng; phản hồi khoa; giao việc cải tiến.	Điều dưỡng và QLCL
Hằng tháng và khi có thay đổi	Bổ sung đào tạo cho người chưa học, nhân viên mới; rà soát dữ liệu; theo dõi khắc phục.	Điều dưỡng trưởng và đầu mối dữ liệu

Nội dung và bằng chứng đào tạo

Chương trình gồm nhận định nhu cầu, giao tiếp dễ hiểu, tư vấn theo thời điểm, nhắc lại và thực hành lại, ghi phiếu chăm sóc, sử dụng tài liệu và xử lý rào cản. Thời lượng, giảng viên và tiêu chuẩn hoàn thành do bệnh viện phê duyệt trước lớp học.

Lưu kế hoạch, tài liệu giảng dạy, danh sách nhân sự thuộc diện theo dõi, danh sách dự học, bài kiểm tra hoặc nhận xét thực hành, kết quả và kế hoạch học bù. Theo dõi 50% → 70% → 90% theo mức mục tiêu; một nhân viên học nhiều buổi chỉ tính một người trong tỷ lệ bao phủ.

Kinh phí và nguồn bảo đảm .....

Người chủ trì và phối hợp .....

Ngày đánh giá lại .....

8 Định nghĩa chỉ số và phương pháp đo

Chỉ số	Cách tính và nguồn
Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh được tập huấn	Tử số: số người duy nhất trong danh sách mẫu số có hồ sơ xác nhận tập huấn kỹ năng tư vấn/GDSK. Mẫu số: tổng điều dưỡng, hộ sinh thuộc danh sách nhân sự bệnh viện tại mốc chốt đã thống nhất. Nguồn: nhân sự và hồ sơ đào tạo. Nhân 100%.
Tỷ lệ lượt điều trị nội trú được tư vấn	Đề xuất theo dõi theo đợt ra viện trong kỳ: tử số là số đợt có ghi nhận điều dưỡng/hộ sinh tư vấn; mẫu số là toàn bộ đợt nội trú kết thúc trong kỳ. Mỗi đợt tính một lần. Nguồn: danh sách ra viện và hồ sơ chăm sóc; đối chiếu phương pháp đoàn đánh giá yêu cầu.
Tỷ lệ hồ sơ có nhận định nhu cầu	Tử số: hồ sơ có nội dung nhận định nhu cầu GDSK; mẫu số: toàn bộ hồ sơ được kiểm tra. Nêu rõ kiểm tra toàn bộ hay chọn mẫu và cỡ mẫu thực tế.
Tỷ lệ người được hỏi nhắc lại hoặc thực hành đúng	Tử số: người đạt tiêu chuẩn đã xác định cho nội dung cá thể; mẫu số: người được đánh giá nội dung đó. Báo cáo riêng từng nội dung, đối tượng và thời điểm; ghi người chưa thể đánh giá.

Trước thu thập phải khóa kỳ đo, định nghĩa mẫu số, cách xử lý nhân sự biến động và người bệnh chuyển khoa/chuyển viện/tử vong. Không tự loại trường hợp khó tư vấn để tăng tỷ lệ; báo cáo riêng lý do trì hoãn hoặc chưa thực hiện. Nếu thay đổi định nghĩa, giải thích ảnh hưởng khi so sánh.

Không có mẫu số thì ghi “không có đối tượng/không tính được”, không ghi 100%. Không làm tròn số dưới ngưỡng thành đạt. Khảo sát mẫu chỉ phản ánh mẫu; muốn suy rộng cần phương pháp phù hợp và nêu hạn chế. Cỡ mẫu do kế hoạch được duyệt xác định, không coi 30 hồ sơ là ngưỡng bắt buộc của C6.2.

Dữ liệu định danh lưu trong hệ thống được phân quyền; bản tổng hợp dùng mã thay tên khi không cần định danh. Đối chiếu số liệu nguồn, kiểm tra trùng và lưu người xác minh trước ký báo cáo.

9 Phiếu ghi nhận tư vấn cá thể BM01

Mã đề xuất C62 BM01. Dùng bổ trợ hoặc tích hợp vào phiếu chăm sóc đã được bệnh viện phê duyệt.

Mã người bệnh và mã đợt điều trị .....

Khoa và giường .....

Ngày giờ và người tư vấn .....

Người tiếp nhận và quan hệ với người bệnh .....

Thời điểm: □ Vào viện □ Trong điều trị □ Trước ra viện □ Khác: .....

Nhu cầu và kiến thức hiện có: .....
.....

Khả năng tiếp nhận: □ Tự tiếp nhận □ Cần người hỗ trợ □ Chưa thể tiếp nhận
Rào cản, lý do và biện pháp hỗ trợ: .....

Mục tiêu cụ thể sau tư vấn: .....
.....

Nội dung và tài liệu sử dụng, mã hoặc phiên bản: .....
.....
.....

Phương pháp: □ Trao đổi □ Minh họa □ Làm mẫu □ Tài liệu □ Khác: .....

Kiểm tra: □ Nhắc lại □ Thực hành lại □ Chưa đánh giá được
Kết quả cụ thể và nội dung chưa đạt: .....
.....

Hướng dẫn bổ sung, đánh giá lại và bàn giao: .....
.....

Người thực hiện ký hoặc xác nhận điện tử .....

Người nhận bàn giao nếu có .....

Không mặc định người bệnh đã hiểu. Ghi nhận theo kết quả thực tế; thực hiện xác nhận theo quy định hồ sơ của bệnh viện.

10 Nhật ký tư vấn nhóm BM02

Ngày giờ và địa điểm .....

Chủ đề và phiên bản tài liệu .....

Người thực hiện và bộ phận phối hợp .....

Đối tượng và mục tiêu buổi tư vấn .....

STT	Mã người tham dự hoặc đợt điều trị	Vai trò NB hoặc người chăm sóc	Nội dung cần bổ sung

Tổng số người tham dự thực tế .....

Cách kiểm tra hiểu biết và kết quả tổng hợp .....

Vấn đề phát hiện và kế hoạch tư vấn riêng .....

Người lập và người kiểm tra .....

Số lượt tham dự không thay thế số người bệnh nội trú duy nhất đã được tư vấn. Chỉ liên kết với chỉ số nội trú khi truy vết được đợt điều trị và người thực hiện là điều dưỡng/hộ sinh.

11 Theo dõi đào tạo và đánh giá thực hành BM03

Tên lớp và ngày tổ chức .....

Giảng viên và tài liệu .....

Tiêu chuẩn hoàn thành đã được phê duyệt .....

Mã nhân viên	Khoa và chức danh	Ngày học	Kết quả và bằng chứng

Phiếu nhận xét thực hành cho một nhân viên: .....

Nội dung quan sát	Đạt	Chưa đạt	Ghi chú
Nhận định và ghi nhu cầu phù hợp			
Chọn nội dung và mục tiêu cá thể			
Diễn đạt dễ hiểu, tôn trọng người bệnh			
Kiểm tra nhắc lại hoặc thực hành lại			
Ghi kết quả, kế hoạch bổ sung và bàn giao			

Nội dung cần học bù và thời hạn .....

Người đánh giá và ngày đánh giá lại .....

Tiêu chuẩn này là công cụ đào tạo đề xuất; không phải bảng điểm bắt buộc do QĐ6858 quy định. Phải lưu bằng chứng thực hành và không tự đánh dấu sẵn kết quả.

12 Kiểm soát tài liệu và lộ trình biên soạn BM04

Tên tài liệu, đối tượng sử dụng .....

Đơn vị soạn và người rà soát chuyên môn .....

Mã, phiên bản và ngày dự kiến áp dụng .....

Nguồn chuyên môn và ngày tra cứu .....

Nội dung rà soát: ☐ Chính xác ☐ Phù hợp đối tượng ☐ Dễ đọc ☐ Minh họa phù hợp
☐ An toàn ☐ Nguồn rõ ☐ Hướng dẫn liên hệ đúng ☐ Kiểm tra QR nếu có

Ý kiến cần sửa .....

Biên bản thảo luận, tổ chức xem xét và ngày .....

Văn bản phê duyệt và người có thẩm quyền .....

Nơi phân phối và cách thu hồi phiên bản cũ .....

Danh mục và lộ trình được xác lập từ số liệu bệnh tật kỳ: .....

Chủ đề và căn cứ ưu tiên	Nguồn hoặc bản hiện có	Đầu mối và hạn hoàn thành	Phê duyệt và nơi dùng

Tách rõ tài liệu cơ quan có thẩm quyền phát hành và tài liệu bệnh viện tự xây dựng. Không ghi “đã phê duyệt” nếu chỉ mới có bản thiết kế hoặc bản in.

13 Bảng kiểm giám sát tại khoa BM05

Khoa, ngày và người giám sát .....

Phạm vi kiểm tra, số hồ sơ và cách chọn .....

Nội dung	Có	Không	Chưa xác minh và bằng chứng
Nhân viên tiếp cận được quy định hiện hành			
Có tài liệu chính thống, dễ thấy và dễ lấy			
Tài liệu tự biên soạn có phê duyệt và phiên bản			
Nhu cầu GDSK được ghi trong phiếu chăm sóc			
Tư vấn phù hợp lúc nhập viện, điều trị, ra viện			
Kiểm tra người bệnh nhắc lại hoặc thực hành lại			
Nội dung chưa hoàn thành được bổ sung, bàn giao			
Dữ liệu đào tạo và tư vấn truy vết được			
Có phản hồi kết quả và theo dõi cải tiến			

Tồn tại cụ thể và nguyên nhân .....

Việc khắc phục, người phụ trách, thời hạn .....

Ngày kiểm tra lại và kết quả .....

Đại diện khoa và người giám sát .....

Bảng kiểm này phục vụ giám sát nội bộ, không thay thế đủ 19 tiểu mục khi xếp mức C6.2. Không cộng các ô “Có” để quy đổi thành mức chất lượng.

14 Phỏng vấn người bệnh và đánh giá hiệu quả BM06

Khoa, ngày và mã đợt điều trị .....

Người trả lời và khả năng tiếp nhận .....

Nội dung đã được hướng dẫn cần kiểm tra .....

Mở đầu: Xin anh/chị kể lại điều đã được nhân viên hướng dẫn. Câu trả lời giúp chúng tôi biết phần nào cần giải thích rõ hơn.

Câu hỏi hoặc yêu cầu cá thể	Kết quả thực tế	Cần hướng dẫn lại
Anh/chị cần làm gì để tự chăm sóc theo hướng dẫn?		
Anh/chị dùng thuốc theo đơn như thế nào?		
Dấu hiệu nào cần báo nhân viên hoặc đi khám ngay?		
Kế hoạch tái khám và nơi liên hệ khi cần?		
Thực hiện lại kỹ năng đã được hướng dẫn nếu phù hợp.		

Tiêu chuẩn đúng của nội dung cá thể đã xác định trước .....

Kết luận, lý do chưa đánh giá được nếu có .....

Tư vấn bổ sung và kết quả kiểm tra lại .....

Người đánh giá .....

Khi đánh giá hiệu quả toàn viện: xác định câu hỏi đánh giá, đối tượng, kỳ đo, cách chọn mẫu, công cụ và tiêu chuẩn; thu thập dữ liệu; phân tích theo khoa/nhóm; nêu sai lệch và hạn chế. Có thể so sánh trước và sau can thiệp nếu cùng định nghĩa và phương pháp. Không kết luận quan hệ nhân quả chỉ từ một khảo sát đơn lẻ.

15 Báo cáo định kỳ và cải tiến BM07

Kỳ báo cáo và đơn vị .....

Nguồn dữ liệu và người xác minh .....

Chỉ số	Tử số	Mẫu số	Tỷ lệ và nhận xét
Nhân viên được tập huấn			
Đợt nội trú được tư vấn			
Hồ sơ có nhận định nhu cầu			
Nhắc lại hoặc thực hành đúng theo nội dung			

Kết quả chính và giới hạn của dữ liệu .....

Tồn tại ưu tiên và phân tích nguyên nhân .....

Đề xuất cải tiến có thể thực hiện .....

Hành động	Người phụ trách	Hạn	Bằng chứng và kết quả đánh giá lại

Hình thức và ngày phản hồi tới các khoa .....

Người nhận hoặc bằng chứng tiếp nhận .....

Ngày theo dõi lại .....

Người lập, rà soát và phê duyệt theo phân cấp .....

Báo cáo phải gắn với hành động thực tế: xác định vấn đề → chọn giải pháp → triển khai → đo lại → điều chỉnh. Lưu cả kết quả chưa đạt và lý do, không chỉ lưu thông báo thành tích.

16 Danh mục minh chứng và tự đánh giá BM08

Kỳ tự đánh giá .....

Người tổng hợp và người kiểm tra .....

Nhóm minh chứng	Tài liệu cần lưu	Mã và vị trí thực tế
MC01 Quy định	Bản được phê duyệt, phạm vi, ngày hiệu lực, bằng chứng phổ biến.	
MC02 Tài liệu chính thống	Danh mục, bản tài liệu, nguồn phát hành và điểm cấp phát.	
MC03 Đào tạo	Chương trình, danh sách nhân sự và tham dự, kết quả, tỷ lệ đã xác minh.	
MC04 Thực hành tư vấn	Phiếu chăm sóc, dữ liệu nội trú, nhật ký và kiểm tra người bệnh.	
MC05 Biên soạn tài liệu	Mô hình bệnh tật, ưu tiên, lộ trình, bản thảo, biên bản và phê duyệt.	
MC06 Hiệu quả và cải tiến	Công cụ, dữ liệu, báo cáo, phản hồi, thực hiện cải tiến và đo lại.	

Lập phụ lục đối chiếu từng tiểu mục 1–19: số mục; mô tả thực tế; mã minh chứng; đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh; người kiểm tra; ngày kiểm tra. Với mục 1–2 ghi rõ tình trạng bất lợi có hay không.

Tình trạng mức 1 có hay không và căn cứ .....

Mức đề xuất sau đối chiếu tích lũy .....

Nội dung còn thiếu và thời hạn hoàn thành .....

Kết luận của người có thẩm quyền .....

Hồ sơ có biểu mẫu đầy đủ chưa đồng nghĩa đã đạt C6.2. Kết luận chỉ lập sau khi kiểm tra hoạt động, số liệu, hiểu biết và kỹ năng thực tế của người bệnh.

17 Tài liệu tham khảo và kiểm tra trước ban hành

[1] Bộ Y tế. Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0. C6.2, trang in 93–94; phương pháp đánh giá tại phần hướng dẫn chung.

Bản toàn văn công bố tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên:

https://trungtamytehuyentanyen.vn/public/uploads/files/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

[2] Bộ Y tế. Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Điểm i khoản 1 Điều 6 và quy định trách nhiệm liên quan. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật:

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

[3] Bộ Y tế. Thông tư 35/2024/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện. Dùng để đối chiếu phạm vi quản lý chất lượng chung, không dùng thay tên hoặc nội dung C6.2:

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=171711

Ngày đối chiếu nguồn: 16/10/2026. Bộ phận phụ trách pháp chế/QLCL bổ sung hướng dẫn đánh giá và văn bản địa phương áp dụng cho kỳ thực tế trước khi trình ký.

Danh sách kiểm tra trước khi ban hành

□ Điền số văn bản, ngày hiệu lực và phân công đúng cơ cấu thực tế.

□ Xác nhận văn bản áp dụng cho kỳ đánh giá và thẩm quyền phê duyệt.

□ Phê duyệt quy định, tài liệu, mục tiêu, kinh phí và lịch triển khai.

□ Thống nhất biểu mẫu với hồ sơ chăm sóc và hệ thống bảo mật dữ liệu.

□ Chốt định nghĩa chỉ số, danh sách nhân sự và nguồn dữ liệu nội trú.

□ Hoàn thành hoạt động rồi mới bổ sung kết quả, biên bản và chữ ký.